2 Betriebliche Gesundheitsförderung/Setting Hochschule

Lernziele

Nach der Lektüre dieses Kapitels

- wissen Sie, wie sich Berufstätigkeit auf Gesundheit auswirkt, und kennen Sie relevante Modelle zum Zusammenhang von Arbeit und Gesundheit,
- können Sie die zentralen Begriffe Betriebliche Gesundheitsförderung und Betriebliches Gesundheitsmanagement differenzieren,
- kennen Sie die gesetzlichen Rahmenbestimmungen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements,
- können Sie verschiedene Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung beschreiben,
- kennen Sie verschiedene Einflussfaktoren auf die Gesundheit von Hochschulangehörigen sowie die Bedingungen von Gesundheitsförderung an Hochschulen,
- besitzen Sie Kenntnisse über verschiedene internationale sowie nationale Initiativen zur Gesundheitsförderung an Hochschulen.

2.1 Erwerbstätigkeit

Für einen Großteil der erwachsenen Menschen ist Erwerbsarbeit ein wesentlicher Lebensbereich. So waren in Deutschland im zweiten Quartal 2023 rund 45.9 Millionen Menschen erwerbstätig (Destatis, 2023).

Erwerbsarbeit sichert den Lebensunterhalt, sorgt für eine Tagesstruktur und ist nicht zuletzt sinnstiftend. Jedoch beansprucht Arbeit auch Zeit – Berufstätige verbringen im Durchschnitt etwa ein Drittel ihres Lebens bei der Arbeit – sowie physische und psychische Energie. Zusätzlich wird sie zumeist unter Rahmenbedingungen geleistet, die von den Einzelnen nicht selbst gestaltet sind. Der letztgenannte Aspekt verweist darauf, dass Erwerbsarbeit in den allermeisten Fällen in die Strukturen von Organisationen (z. B. Produktionsbetriebe, Dienstleistungsunternehmen, Verwaltungsbehörden) eingebettet ist. Die Inhalte und Voraussetzungen der überwiegenden Arten von Arbeit in solchen Organisationen unterliegen außerdem einem stetigen Veränderungsprozess. Vor allem die Art, in der moderne Erwerbsarbeit stattfindet, ist durch sich kontinuierlich wandelnde Rahmenbedingungen geprägt, die gesundheitsrelevant sind oder sein können (Badura et al., 2010). Zu diesen gehören:

- Veränderungen der Arbeitsanforderungen (z. B. Einsatz von Kommunikationstechnologien, Notwendigkeit ständiger Erneuerung und Erweiterung von Wissen und Fertigkeiten),
- Veränderungen der Arbeitsbedingungen (z. B. Schicht- oder Teilzeitarbeit),
- häufige Umstrukturierungen in Unternehmen,
- demografische Entwicklung und in der Folge längere Lebensarbeitszeit,
- Veränderungen der Wirtschaftssektoren, insbesondere Wachstum der Dienstleistungs- und Informationssektoren.

Es gibt somit vielfältige Gründe, Erwerbsarbeit unter dem Gesichtspunkt ihrer Relevanz für das körperliche und psychische Befinden zu betrachten und die Notwendigkeiten und Möglichkeiten der Gesundheitsförderung in diesem Lebensbereich zu analysieren.

2.1.1 Gesundheitsrelevante Aspekte von Arbeit

Sowohl für positive als auch potenziell belastende Begleiterscheinungen und Folgen der Erwerbstätigkeit gibt es empirisch gestützte Hinweise.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Insgesamt besitzt die Berufstätigkeit für die meisten Menschen eine hohe persönliche Bedeutsamkeit. Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung (Gaspar & Hollmann, 2015) an über 1,000 Erwerbstätigen war der Stellenwert der Arbeit hinter dem Bereich Familie und Partnerschaft angesiedelt, aber vor Freizeit und weit vor gesellschaftlichem Engagement – unabhängig von Geschlecht und Alter. Eine hohe Relevanz hatte der Beruf vorrangig für alleinstehende, männliche und ältere Befragte; eine niedrigere Relevanz besonders für Frauen, die in Teilzeit arbeiten und in einer Partnerschaft leben. Letztgenannter Befund ist auch insofern bedeutsam, da die Hälfte der teilzeitbeschäftigten Frauen ihre Arbeitszeit gerne erhöhen würden (Wanger, 2011). Die Zufriedenheit mit der eigenen Arbeit wurde im Schnitt von fast 80 % der befragten Arbeitnehmer:innen positiv bewertet, wobei Frauen eine tendenziell höhere Zufriedenheit mit ihrer Arbeit berichteten (Gaspar & Hollmann, 2015).

Neben diesen positiven Aspekten haben jedoch gerade Belastungen, die mit Arbeit zusammenhängen, eine potenziell negative gesundheitsrelevante Bedeutung. Ein Belastungsfaktor sind zum Beispiel Überstunden. Den Ergebnissen einer online-Umfrage der Statistikdatenbank Statista mit 1,059 Vollzeit-Beschäftigten zufolge arbeiteten 33 % bis zu 45 Stunden und weitere 20 % der Befragten mehr als 45 Stunden pro Woche (Statista, 2017). Neben dem Arbeitsumfang werden auch bestimmte Arbeitsbedingungen als belastend wahrgenommen. Als physische Belastungsfaktoren von Beschäftigten gilt schwere, muskelbeanspruchende sowie sich wiederholende, manuelle Arbeit. Etwa 30 % der Beschäftigten, die schwere Lasten von Hand bewegen, leiden unter Rückenschmerzen. Durch Heben und Tragen verursachte Rückenbeschwerden sind die häufigste Ursache für Arbeitsunfähigkeit (Landesanstalt für Arbeitsschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, 2002).

Eine Forsa-Umfrage im Auftrag der Techniker Krankenkasse (Techniker Krankenkasse, 2016) fokussierte psychische Belastungsfaktoren von Vollzeitbeschäftigten. Als besonders psychisch belastend erlebt wurden:

- zu viel Arbeit (69 %)
- Termindruck (65 %)
- Störungen (56 %)
- mangelnde Anerkennung (43 %)
- äußere Einflüsse wie Lärm, Licht, Temperatur (37 %)
- Unvereinbarkeit mit der Familie (29 %).

Zudem gaben die Befragten an, sowohl am Wochenende (36 %) als auch im Urlaub (26 %) nicht richtig von der Arbeit abschalten zu können. Fast ein Fünftel der Befragten äußerte die Besorgnis, dem Arbeitstempo nicht mehr lange gewachsen zu sein (Techniker Krankenkasse, 2016).

2.1.2 Gesundheitliche Beschwerden und Krankheiten im Kontext von Arbeit

Gesundheitliche Probleme und Krankheiten können unabhängig von der Arbeit oder durch sie (mit-)bedingt auftreten. Sie werden aber in jedem Fall im Arbeitskontext sichtbar, wenn sie zu einer Arbeitsunfähigkeit führen (siehe Kasten 2.1).

Arbeitsunfähig ist, wer aufgrund von Krankheit seine zuletzt ausgeübte Tätigkeit nicht mehr oder nur unter der Gefahr der Erkrankungsverschlimmerung ausführen kann (SGB V, § 92 Abs.1 Satz 2 Nr. 7). Der aktuelle Gesundheitsreport der Techniker Krankenkasse (2023a)über ihre 5.6 Millionen sozialversicherungspflichtig beschäftigten oder arbeitslos gemeldeten Mitglieder ergab für das Jahr 2022 insgesamt 8.54 Millionen Fälle von Arbeitsunfähigkeit (Mehrfachausfälle pro

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

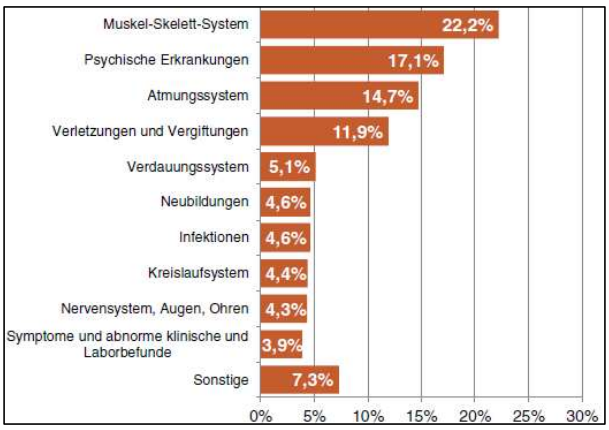
Person möglich) und 110.12 Millionen Fehltage mit einem Krankenstand (Krankheitszeit relativiert an Soll-Arbeitszeit) von 5.20 %. Dies entspricht einer durchschnittlichen krankheitsbedingten Fehlzeit von 19.0 Tagen pro Erwerbsperson.

Kasten 2.1. Definition und Häufigkeit von Arbeitsunfähigkeit. Nach Techniker Krankenkasse, 2023a

Bei den Gründen für eine Arbeitsunfähigkeit treten einige Krankheitsgruppen besonders häufig auf. Exemplarisch lassen sich hier die Daten des Gesundheitsreports der Deutschen Angestellten Krankenkasse (DAK) aus dem Jahr 2016 anführen (Marschall et al., 2017; siehe Abbildung 2.1).

Abbildung 2.1

Prozentuale Anteile der häufigsten Krankheitsarten an den Arbeitsunfähigkeitstagen der knapp 6 Millionen Mitglieder der DAK im Jahr 2016. Aus Marschall et al., 2017.



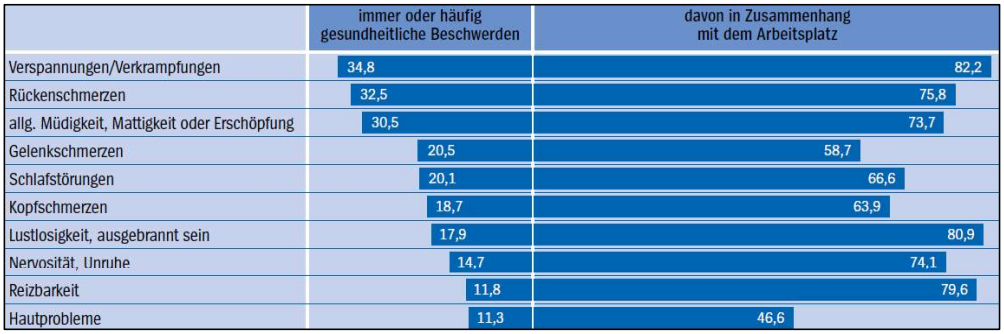
Krankheiten des Muskel- und Skelettsystems machten den größten Anteil der somatischen Erkrankungen aus, gefolgt von Atemwegserkrankungen. Bei der insgesamt zweithäufigsten Gruppe der psychischen Erkrankungen führten depressive Episoden beispielsweise rezidivierende depressive Störungen zu den häufigsten Arbeitsunfähigkeitstagen.

Unabhängig davon, ob gesundheitliche Beeinträchtigungen zu einer Arbeitsunfähigkeit führen oder nicht, werden sie häufig von den Betroffenen als mit der Arbeitssituation zusammenhängend wahrgenommen. Eine Umfrage an über 30,000 Versicherten des Verbunds der Allgemeinen Ortskrankenkassen zeigte beispielsweise, dass insbesondere Verspannungen, Lustlosigkeit und Reizbarkeit von jeweils ungefähr 80 % der Befragten mit dem Arbeitsplatz in Verbindung gebracht werden (Verbund der Allgemeinen Ortskrankenkassen, 2016; AOK; siehe Abbildung 2.2).

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Abbildung 2.2

Häufigkeit der gesundheitlichen Beschwerden und Zusammenhang mit dem Arbeitsplatz. Aus AOK, 2016, S. 8



2.2 Betriebliche Gesundheitsförderung

Betriebliche Gesundheitsförderung wurde etabliert, um den potenziell gesundheitsrelevanten Arbeitsbedingungen möglichst umfassend zu begegnen. Sie soll dabei gleichermaßen den Bedürfnissen der Erwerbstätigen und den Zielsetzungen der Betriebe dienen.

2.2.1 Begriffsbestimmung und Leitlinien Betrieblicher Gesundheitsförderung

Die allgemeine Ausrichtung Betrieblicher Gesundheitsförderung ist eng verknüpft mit dem Gesundheitsverständnis der Weltgesundheitsorganisation (WHO; Grad, 2002) als einem Zustand völligen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens (siehe Kurs 1, Kapitel 1 „Einführung in die Gesundheitspsychologie“ und Kurs 2, Kapitel 1 „Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention“). Ausgehend von diesem Gesundheitsverständnis wurde 1997 von dem European Network for Workplace Health Promotion (ENWHP; http://www.enwhp.org/) die Luxemburger Deklaration zur Betrieblichen Gesundheitsförderung in der Europäischen Union formuliert (Deutsches Netzwerk für Betriebliche Gesundheitsförderung, 2014). In dieser Deklaration wird die Zielsetzung Betrieblicher Gesundheitsförderung folgendermaßen beschrieben (siehe Kasten 2.2).

Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) umfasst alle gemeinsamen Maßnahmen von Arbeitgeber:innen, Arbeitnehmer:innen und Gesellschaft zur Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz. Dies kann durch eine Verknüpfung folgender Ansätze erreicht werden:

- Verbesserung der Arbeitsorganisation und der Arbeitsbedingungen,
- Förderung einer aktiven Beteiligung von Mitarbeiter:innen,
- Stärkung persönlicher Kompetenzen.

Kasten 2.2. Begriffsbestimmung Betrieblicher Gesundheitsförderung im Wortlaut der Luxemburger Deklaration. Aus Deutsches Netzwerk für Betriebliche Gesundheitsförderung, 2014.

Das Vorgehen bei der Gestaltung Betrieblicher Gesundheitsförderung soll dabei entlang der Leitlinien Partizipation, Integration, Projektmanagement und Ganzheitlichkeit ausgerichtet sein (Deutsches Netzwerk für Betriebliche Gesundheitsförderung, 2014). *Partizipation* bezieht sich auf die Forderung nach Einbezug der gesamten Belegschaft; *Integration* auf die Berücksichtigung Betrieblicher Gesundheitsförderung bei allen wichtigen Entscheidungen in allen Bereichen eines Unternehmens. Die systematische Analyse, Planung, Durchführung, Verlaufskontrolle und Evaluation soll durch ein entsprechendes *Projektmanagement* gewährleistet werden.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Ganzheitlichkeit bezieht sich zum einen auf den Einbezug von Maßnahmen, die sowohl an dem individuellen Verhalten als auch an den Kontextbedingungen der Arbeit ansetzen (siehe Kurs 2, Kapitel 1 „Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention"). Zum anderen wird hierunter der gleichzeitige Einsatz von risikoreduzierenden Maßnahmen als Maßnahmen zum Aufbau und zur Stärkung von Schutzfaktoren und Gesundheitsressourcen verstanden.

2.2.2 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Ein mit der Betrieblichen Gesundheitsförderung verwandtes Konzept ist das Betriebliche Gesundheitsmanagement, das sich definieren lässt als „die Entwicklung betrieblicher Rahmenbedingungen, Strukturen und Prozesse, welche die gesundheitsfördernde Gestaltung von Arbeit und Organisation sowie die Befähigung zum gesundheitsfördernden Verhalten der Beschäftigten zum Ziel hat." (Kiesche, 2013). Das Betriebliche Gesundheitsmanagement lässt sich somit als die Organisation von Gesundheit in Betrieben verstehen. Die Art und Umsetzung der Maßnahmen sind dabei abhängig von den übergeordneten Unternehmenszielen, das heißt den Werten und Leitbildern, und den vorhandenen oder zu schaffenden Strukturen für die Umsetzung der Maßnahmen (Bamberg et al., 2011).

Das Verhältnis von Betrieblicher Gesundheitsförderung und Betrieblichem Gesundheitsmanagement wird in der Literatur und der Praxis unterschiedlich verstanden; teilweise werden die Begriffe bedeutungsgleich verwendet, teilweise werden sie als einander über- oder untergeordnet verstanden. Video 2.1 veranschaulicht, wie Betriebliches Gesundheitsmanagement als Basis für Betriebliche Gesundheitsförderung aufgefasst werden kann.

Video 2.1. Betriebliche Gesundheitsförderung versus Betriebliches Gesundheitsmanagement (walk4fun, Martina Meister). Verfügbar unter http://youtu.be/iC4_OP_on8w

Das Betriebliche Gesundheitsmanagement bezieht sich auf verschiedene Handlungsfelder, in denen die Betriebliche Gesundheitsförderung relevant ist. Bamberg et al. (2011) unterscheiden dabei zwischen Gesundheitsmanagement im engeren (direkt auf Gesundheit bezogenen) und weiteren Sinne (auf die Organisationsstrukturen bezogen) (siehe Kasten 2.3). Auf einer übergeordneten Ebene umfasst das Betriebliche Gesundheitsmanagement weiterhin die Koordination innerhalb und zwischen diesen Handlungsfeldern.

Gesundheitsmanagement im engeren Sinn:

- Arbeits- und Gesundheitsschutz (z. B. ergonomische Gestaltung von Arbeitsplätzen, sicherer Umgang mit Gefahrstoffen)
- Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM; z. B. Bereitstellung von technischen Hilfen oder eine veränderte Arbeitsorganisation für erkrankte Beschäftigte mit dem Ziel des Erhalts der Leistungsfähigkeit und der Gesundheit)
- Fehlzeitenmanagement (Maßnahmen zur Identifizierung von Fehlzeitursachen und zur Reduktion von Fehlzeiten)
- Gesundheitsförderung
- medizinische und psychosoziale Betreuung im Unternehmen

Gesundheitsmanagement im weiteren Sinn:

- Arbeitsgestaltung (Maßnahmen zur gesundheitsfördernden Gestaltung von Arbeitsaufgaben und -bedingungen, z. B. flexible Arbeitszeitregelungen)

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

- Personalentwicklung/Human Resources Management (Aufbau, Erhalt und Entwicklung personenbezogener Kompetenzen, die gesundheitsbezogene Implikationen haben, z. B. Führungskräftetraining zur Problemdeeskalation)
- Organisationsgestaltung und Organisationsentwicklung (Veränderungen der betrieblichen Strukturen und Prozesse, die Auswirkungen auf die Gesundheit der Beschäftigten haben, zum Beispiel Einsatz neuer Kommunikationstechnologien)

Kasten 2.3. Handlungsfelder des Betrieblichen Gesundheitsmanagements. Bamberg et al., 2011.

2.2.3 Gesetzliche Verankerung von Betrieblicher Gesundheitsförderung und Betrieblichem Gesundheitsmanagement

Die Einführung von Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung und das Betriebliche Gesundheitsmanagement erfolgen nicht alleine im Ermessen der Leitungsebene von Betrieben, sondern unterliegen gesetzlichen Rahmenbedingungen. Diese sind hauptsächlich im Sozialgesetzbuch sowie dem Arbeitsschutzgesetz festgehalten. So wird im *Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention* (siehe Kurs 2, Kapitel 1 „Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention") auf Lebenswelten Bezug genommen, in denen die Gesundheit von Menschen gestärkt werden soll. Für die Lebenswelt „Betrieb" wird dabei die Zusammenarbeit von Ländern und Kommunen sowie von Krankenkassen, Renten-, Unfall- und Pflegeversicherungen sowie Behörden im Bereich Arbeitsschutz und Betrieblicher Gesundheitsförderung gesetzlich geregelt. Die *Nationale Präventionskonferenz* hat im Sinne einer zielgerichteten Prävention und Gesundheitsförderung und zur Stärkung der Zusammenarbeit der Zuständigen bundeseinheitliche trägerübergreifende Empfehlungen beschlossen, die von den genannten Trägern zu berücksichtigen sind (Bundesrahmenempfehlungen nach § 20d Abs. 3 SGB V; GKV-Spitzenverband et al., 2016).

Der Schutz vor gesundheitlichen Schädigungen (z. B. Unfällen), die während der Arbeit und verursacht durch Arbeitsbedingungen entstehen können, ist bereits seit langem national und international Gegenstand gesetzlicher Regelungen. Auf europäischer Ebene existiert die *Europäische Rahmenrichtlinie für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit* aus dem Jahr 1989 (Europäische Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz, 1989; 89/391/EWG). Dort heißt es in Artikel 5, Satz 1: „Der Arbeitgeber ist verpflichtet, für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer in Bezug auf alle Aspekte, die die Arbeit betreffen, zu sorgen". Dieser Ansatz des europäischen Arbeitsschutzes wurde maßgeblich durch die Gesundheitsdefinition der Internationale Arbeitsorganisation (1981) beeinflusst: Gesundheit ist „[…] nicht nur das Freisein von Krankheit oder Gebrechen, sondern umfasst auch die physischen und geistig-seelischen Faktoren, die sich auf die Gesundheit auswirken und die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Sicherheit und der Gesundheit bei der Arbeit stehen." (Art. 3, Punkt e).

In Deutschland regelt das im Jahr 1996 in Kraft getretene *Arbeitsschutzgesetz* (ArbSchG) Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen bei der Arbeit und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie zur menschengerechten Gestaltung der Arbeit (§ 2 Abs. 1). Erweiterungen des Präventionsansatzes werden durch § 4 deutlich. Nach Absatz 1 ist „Arbeit […] so zu gestalten, dass eine Gefährdung für das Leben sowie die physische und die psychische Gesundheit möglichst vermieden und die verbleibende Gefährdung möglichst gering gehalten wird.". Von Arbeitgeber:innen wird weiterhin ein dauerhafter kontinuierlicher Verbesserungsprozess (§ 3 Abs. 1) sowie eine geeignete betriebliche Organisations- beziehungsweise Führungsstruktur (§ 3 Abs. 2) verlangt. Darüber hinaus ist von Arbeitgeber:innen eine regelmäßige Gefährdungsbeurteilung durchzuführen, wobei ebenfalls psychische

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Belastungen zu prüfen sind (§ 5 Abs. 1). Daneben bestehen Rechte und Pflichten für Beschäftigte. Diese sollen für ihre eigene Sicherheit und diejenige der Kolleg:innen sorgen (§ 15 Abs. 1) sowie die Arbeitgeber:innen bei der Umsetzung des Arbeitsschutzes unterstützen (§ 16 Abs. 2). Weiterhin existieren *Rechtsverordnungen* mit Vorgaben für bestimmte Gefährdungsarten und Tätigkeiten (z. B. Arbeitsstättenverordnung [ArbStättV|, 2004). Im Hinblick auf die Betriebliche Gesundheitsförderung sind besonders Verordnungen für folgende Bereiche relevant: Lastenheben, Lärm, Vibration und Bildschirmtätigkeit. Beispielsweise sollen bei Bildschirmtätigkeiten Belastungsanalysen zum Sehvermögen und zu körperlichen Problemen und ebenso die Analyse von psychischer Belastung (vgl. § 5 ArbSchG; § 3 ArbStättV; Beck et al., 2012) erfolgen.

2.3 Psychologische Modelle zum Zusammenhang von Arbeit und psychischem/physischem Befinden

Zwischen den Charakteristika von Arbeit (z. B. ihren Inhalten, ihrer Gestaltung), der Person, die mit dieser Arbeit konfrontiert ist, und den gesundheits- und krankheitsbezogenen Folgen von Arbeit bestehen vielfältige und teilweise sehr komplexe Beziehungen. Für die Zusammenhänge zwischen bestimmten schädlichen Bedingungen der Arbeitsumwelt und schwerwiegenden gesundheitlichen Schäden gibt es erklärungsstarke bio-medizinische Modelle; beispielsweise für die Schädigung von Lungengewebe durch die Einatmung von Asbestfasern oder für die Steigerung des Hautkrebsrisikos bei Menschen, die überwiegend im Freien arbeiten. Für andere Zusammenhänge, bei denen neben überwiegend biologischen auch psychosoziale Faktoren maßgeblich beteiligt sind, existieren entsprechende erweiterte theoretische Prozessannahmen. Der Geltungsbereich dieser theoretischen Annahmen und psychologischen Erklärungsmodelle umfasst dabei sowohl gesundheitsbeeinträchtigende (z. B. Überforderung, Suchtmittelgebrauch) als auch -fördernde (z. B. Zufriedenheit, wahrgenommene Kompetenzsteigerung) Outcomes der Interaktion zwischen Arbeit und Person.

Im Folgenden werden ausgewählte Theorien und Erklärungsmodelle zu den Zusammenhängen zwischen Beruf und Gesundheit vorgestellt. Für die Erklärung, wie sich psychosoziale Belastungen auf die Gesundheit auswirken, können moderne Stresstheorien eine Grundlage liefern. Entsprechend dieser Theorien ist psychosoziale Belastung die Ganzheit psychosozialer Stressoren und individueller Bewältigungsmuster. Chronische oder immer wiederkehrende psychosoziale Belastung wirkt sich über eine dauerhafte Aktivierung des zentralen Nervensystems durch Stresshormonausschüttung (Stressreaktion) auf den Körper aus. Daneben beeinflusst psychosoziale Belastung die Gesundheit über das Verhalten, zum Beispiel in Form von Kompensation erfahrener Belastung durch Zigarettenrauchen (siehe auch Kurs 1, Kapitel 7 „Stress und Stressbewältigung“). Diese beiden Wirkungsweisen führen in langfristiger Konsequenz beispielsweise zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder psychischen Symptomen (Peter, 2002).

2.3.1 Demand-Control-/Anforderungs-Kontroll-Modell

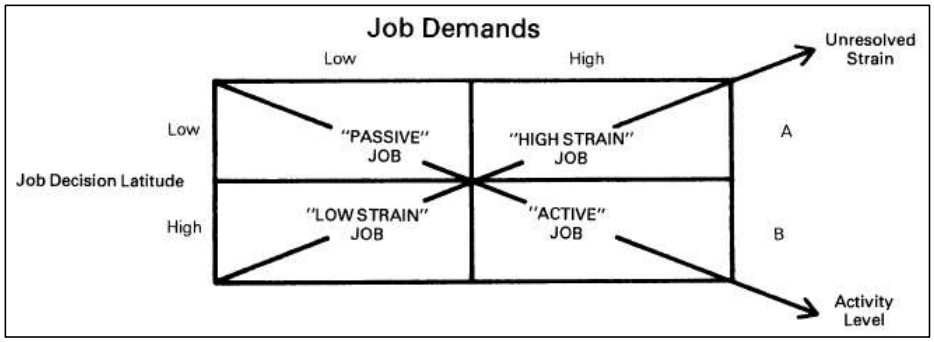
Im Demand-Control-/Anforderungs-Kontroll-Modell (Karasek, 1979; siehe Abbildung 2.3) wird angenommen, dass gesundheitliche Beeinträchtigung eine Folge des Zusammentreffens von hohen psychologischen Anforderungen am Arbeitsplatz (v. a. Zeitdruck) und niedrigen Einfluss- beziehungsweise Kontrollmöglichkeiten (Lernen von Neuem, berufliche Einbringung eigener Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie Treffen eigener Entscheidungen) ist. Eine solche arbeitsbezogene Belastungskonstellation („High Strain Job“) führt zu Stressreaktionen und

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

langfristig zu einem erhöhten Risiko für erhebliche chronische, psychische und physische Erkrankungen. Geringe Anforderungen und geringe Kontrolle („Passive Job") rufen Apathie und Langeweile und im schlimmeren Fall ebenfalls psychische und physische Krankheiten hervor. Geringe Anforderungen und hohe Kontrolle („Low Strain Job") gehen mit einer niedrigen psychischen Belastung einher. Die Konstellation hohe Anforderungen und hohe Kontrolle („Active Job") reduziert Gesundheitsrisiken, indem beispielsweise neue Fähigkeiten oder Verhaltensweisen erworben werden, die förderlich auf die psychische und/oder körperliche Gesundheit wirken können (de Witte et al., 2007).

Abbildung 2.3

Anforderungs-Kontroll-Modell. Aus Karasek, 1979, S. 288



Das Anforderungs-Kontroll-Modell zählt zu den klassischen Modellen im Kontext der Betrieblichen Gesundheitsförderung. Dementsprechend zielt neuere Forschung vermehrt auf die Überprüfung modernerer Modelle (wie zum Beispiel das Job Demands-Resources Modell, siehe Abschnitt 2.3.4) ab. Dennoch lässt sich im Licht früherer Studienergebnisse das Anforderungs-Kontroll-Modell empirisch größtenteils absichern. Beispielsweise zeigte sich bei einer Untersuchung von über 100 zum Teil prospektiven Studien, dass von Arbeiter:innen mit einem High Strain Job das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen um den Faktor 1.4 bis 4.0 und für Bluthochdruck um bis zu 7.2 erhöht ist (Belkic et al., 2000). In einer Interventionsstudie mit einem schwedischen Automobilhersteller führten Verbesserungen in Autonomie und Entwicklungsmöglichkeiten von Beschäftigten zu besseren Blutfettwerten und einer höheren Arbeitszufriedenheit im Vergleich zu einer Kontrollgruppe (Orth-Gomér et al., 1994). Insgesamt sind High Strain Jobs mit zeitlich vorgelagerten Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen assoziiert, was die Relevanz von Job Strain in der Primärprävention verdeutlicht.

2.3.2 Demand-Control-Support-/Anforderungs-Kontroll-Unterstützungs-Modell

Im Anforderungs-Kontroll-Unterstützungs-Modell wurde das Anforderungs-Kontroll-Modell um eine dritte Dimension in Form von sozialer Unterstützung bei der Arbeit erweitert (Johnson et al., 1989). Demnach führt soziale Unterstützung durch Kolleg:innen sowie durch Vorgesetzte zu einer Abmilderung der gesundheitsschädigenden Wirkung von High Strain Jobs. Empirisch zeigt sich – unabhängig von der Kontrolle – eine Abmilderung des negativen Effekts von hoher Arbeitsbelastung auf die Arbeitszufriedenheit und das Depersonalisationsausmaß durch hohe soziale Unterstützung von Vorgesetzten und Kolleg:innen sowie hoher nichtarbeitsbezogener Unterstützung zum Beispiel durch Partner:innen, Familie oder Freund:innen (Sargent & Terry, 2000).. Entsprechend des Reviews von Häusser et al. (2010) sind die Dimensionen Anforderung, Kontrolle und soziale Unterstützung (siehe auch Kurs 1, Kapitel 3 „Soziale Integration und soziale Unterstützung") mit arbeitsbezogenem Wohlbefinden assoziiert.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Anwendungsbezogen zeigt sich beispielhaft in einer Untersuchung von Blom et al. (2016) mit über 5,500 Personen, dass Manager:innen im Vergleich zu Nichtmanager:innen mehr Anforderungen und Kontrolle („Active Job") in ihrer Arbeit erleben. Frauen haben ein höheres Risiko für Burnout, da sie mehr Anforderung ohne Ausgleich durch Kontrolle („High Strain Job") erleben. Insgesamt werden Zusammenhänge von Anforderungen und Kontrolle mit Burnout durch die familiäre Umgebung beeinflusst – dies stützt die Annahmen des Modells. Video 2.2 veranschaulicht das arbeitsbezogene Anforderungs-Kontroll-Unterstützungs-Modell.

Wie bei seinem Vorläufer gilt auch beim Anforderungs-Kontroll-Unterstützungs-Modell zu bedenken, dass eine Aussage hinsichtlich einer aktuellen empirischen Absicherung aufgrund fehlender neuer Forschungsbefunde nur eingeschränkt möglich ist.

Video 2.2. Job-Demand-Control-Support Model (Jonathon Martinez). Verfügbar unter https://youtu.be/-Fj3qBEL0sU

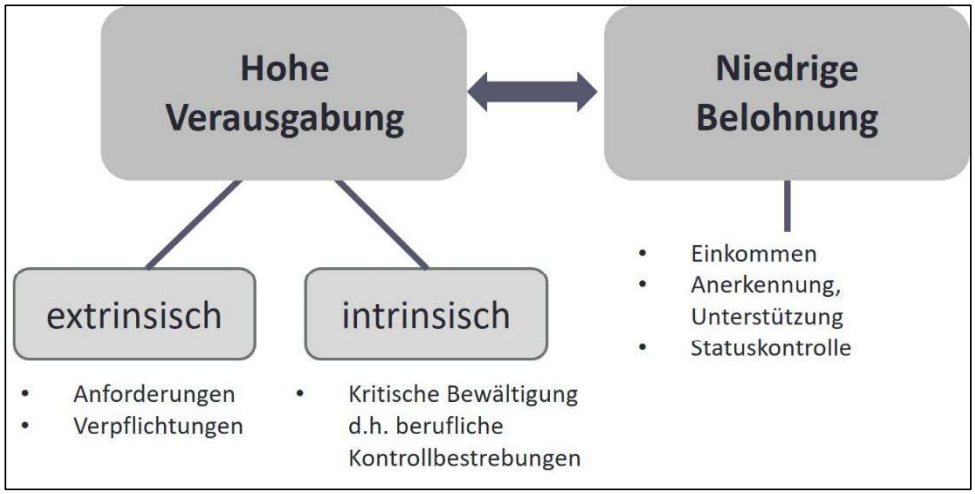
2.3.3 Effort-Reward-Imbalance-Model/Modell beruflicher Gratifikationskrisen

Im Modell beruflicher Gratifikationskrisen (Siegrist, 1996; siehe Abbildung 2.4) wird angenommen, dass Belastungen im Erwerbsleben durch unausgeglichene soziale Austauschbeziehungen entstehen. Stehen den Leistungsverausgabungen (z. B. durch Zeitdruck, Verantwortung, inkonsistente Anforderungen, Arbeitsintensivierung, Überstunden und körperlich anstrengende Arbeit) keine angemessenen Belohnungen (z. B. Lohn und Gehalt, Wertschätzung durch Kolleg:innen sowie Vorgesetzte, Aufstiegsmöglichkeiten und Arbeitsplatzsicherheit) gegenüber, entsteht Stressbelastung durch eine solche berufliche Gratifikationskrise.

Das Modell beruflicher Gratifikationskrisen definiert die sogenannte Verausgabungsneigung als gesundheitsbeeinträchtigendes Bewältigungsverhalten. Dabei handelt es sich um ein Muster von Einstellungen, Verhalten und Emotionen, das durch exzessive Verausgabung und gleichzeitig einen starken Wunsch nach Anerkennung gekennzeichnet ist.

Abbildung 2.4

Das Modell beruflicher Gratifikationskrisen. Aus Siegrist, 1996, S. 99



Das Modell beruflicher Gratifikationskrisen zählt ebenso zu den klassischen Modellen und gilt im Kontext früherer Forschung als empirisch erfolgreich geprüft. So zeigten rund 50 zum Teil prospektive Studien signifikante Zusammenhänge zwischen Indikatoren beruflicher Gratifikationskrisen und gesundheitlichen Risiken. Bei Personen mit Gratifikationskrisen ist das Risiko für koronare Herzerkrankungen um den Faktor 1.2 bis 9.0 erhöht; für kardiovaskuläre

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Risikofaktoren um den Faktor 1.2 bis 6.7 und für psychische Störungen, wie Major Depression, sogar bis zu Faktor 18.6 (Rau et al., 2010). Darüber hinaus fanden sich auch erhöhte Risiken für Bluthochdruck, Erwerbsunfähigkeit aufgrund von Depression, Typ-2-Diabetes und Alkoholabhängigkeit (Siegrist, 2016). Gratifikationskrisen wirken geschlechtsspezifisch, indem Herz-Kreislauf-Risiken für Männer mit extrinsischen Komponenten von Gratifikationskrisen, das heißt den Arbeitsbedingungen, und für Frauen mit der intrinsischen Komponente, das heißt dem Bewältigungsmuster Verausgabungsneigung, assoziiert sind (Peter et al., 2006). Insgesamt ist daher die Berücksichtigung von Gratifikationskrisen in der Primärprävention ebenfalls relevant. In Video 2.3 veranschaulicht Prof. Dr. Johannes Siegrist seine Forschung und Erkenntnisse basierend auf dem Modell beruflicher Gratifikationskrisen.

Video 2.3. Interview mit Prof. Dr. Johannes Siegrist (Präventions-Summit). Verfügbar unter https://youtu.be/jpWP0FNlhhY

Das Anforderungs-Kontroll-(Unterstützungs-)Modell und das Modell beruflicher Gratifikationskrisen weisen einige Gemeinsamkeiten und ebenso eine Reihe von Unterschieden auf. Beide Modelle haben vergleichbare stresstheoretische Annahmen und Erhebungsmethoden – wobei im Anforderungs-Kontroll-Modell die Belastungshäufigkeit und im Modell beruflicher Gratifikationskrisen die Belastungsintensität erfasst wird. Zu den grundlegenden Unterschieden zählt die Thematisierung beruflicher Entlastungserfahrungen: Das Anforderungs-Kontroll-Modell fokussiert Handlungs- und Entscheidungsspielräume, während das Modell beruflicher Gratifikationskrisen berufliche Belohnungen fokussiert. Im Gegensatz zum Anforderungs-Kontroll-Modell werden im Modell beruflicher Gratifikationskrisen marktwirtschaftliche Rahmenbedingungen von Erwerbstätigkeit sowie das individuelle Bewältigungsverhalten berücksichtigt. Aufgrund dieser Unterschiede ist zu erwarten, dass beide Modelle verschiedene Aspekte beruflicher Belastung adressieren. Eine Kombination beider Modelle könnte zu einer besseren Vorhersage gesundheitlicher Risiken führen (Peter et al., 2002).

2.3.4 Job Demands-Resources Model of Burnout/Anforderungs-Ressourcen Modell

Die Einschränkung der berücksichtigten Faktoren im Anforderungs-Kontroll-(Unterstützungs-)Modell (Johnson et al., 1989; Karasek, 1979) auf Belastungshäufigkeit und Handlungsspielräume sowie im Modell beruflicher Gratifikationskrisen (Siegrist, 1996) auf Belastungsintensität und Gratifikation versucht das Anforderungs-Ressourcen Modell (*Job Demands-Resources (JD-R) Model*) von Demerouti et al. (2001)zu überwinden. Im JD-R Modell werden Anforderungen allgemeiner definiert als physische, soziale und organisationale Arbeitsfaktoren, welche Anstrengung erfordern und dadurch als Belastung wahrgenommen werden. Ressourcen werden definiert als physische, soziale und organisationale Arbeitsfaktoren, welche das Erreichen von Zielen erleichtern, Anforderungen reduzieren und persönliches Wachstum und Entwicklung unterstützen (Demerouti et al., 2001, S. 501).Die Forschenden sehen einen wesentlichen Vorteil der allgemeineren Definition von Anforderungen und Ressourcen darin, dass das Modell dadurch in unterschiedlichen Unternehmen (z. B. Industrie oder Dienstleistungsunternehmen) und auch auf verschiedenen Hierarchieebenen (z. B. Führungsebene, mittleres Management, Arbeitende ohne Führungsaufgaben) angewendet werden kann (Bakker & Demerouti, 2007).

Der Begriff und das Konstrukt *Burnout* geht auf die Arbeiten von (Freudenberger, 1974) und (Maslach, 1976, 1982) zurück und wird in der aktuellen, 11. Auflage des *Internationale Classification of Diseases* (ICD-11; World Health Organization [WHO], 2022) als ein Syndrom

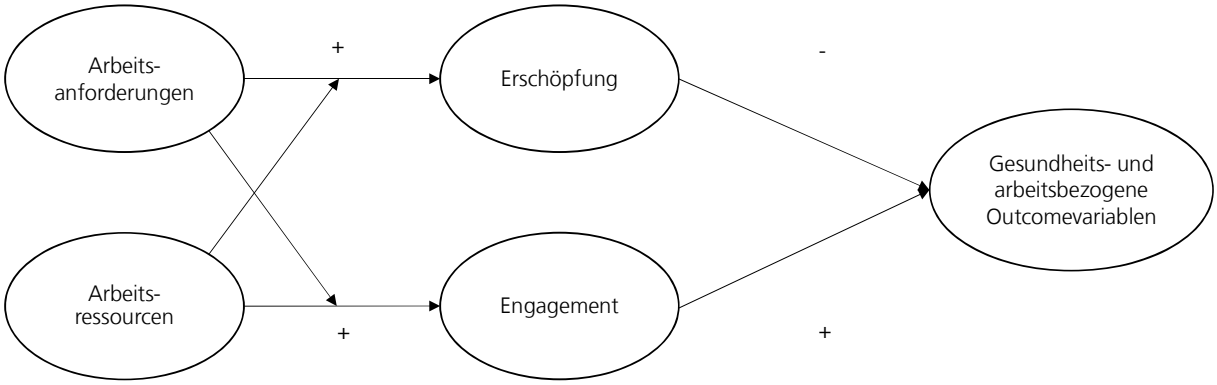
Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

definiert „[…] das als Folge von chronischem Stress am Arbeitsplatz konzeptualisiert wird, der nicht erfolgreich bewältigt wurde. Es ist durch drei Dimensionen gekennzeichnet: 1) Gefühle der Energieerschöpfung oder Erschöpfung 2) Erhöhte mentale Distanz zur Arbeit oder Gefühle von Negativismus oder Zynismus in Bezug auf die Arbeit 3) Ein Gefühl der Ineffektivität und des Mangels an Leistung." Abbildung 2.5 verdeutlicht, dass im JD-R Modell Burnout anhand von zwei Dimensionen konzeptualisiert wird: Erschöpfung und (Dis-)Engagement. Dem Modell zufolge entstehen diese beiden Zustände unabhängig voneinander. Im gesundheitsbeeinträchtigenden Pfad führen hohe Anforderungen zu Erschöpfung. Im motivationalen Pfad führen (fehlende) Ressourcen zu (Dis-)Engagement. Burnout entsteht in der Folge dann, wenn Anforderungen hoch und Ressourcen niedrig sind (Demerouti et al., 2001). Die beiden Burnoutdimensionen mediieren außerdem den Einfluss von Anforderungen und Ressourcen auf gesundheits- und leistungsbezogene Outcomevariablen wie beispielsweise Lebenszufriedenheit (siehe etwaDemerouti et al., 2000).

Das JD-R Modell wurde in den folgenden Jahren weiter entwickelt. Unter anderem untersuchten Bakker und Demerouti (2007) Interaktionseffekte, also den Einfluss von Ressourcen auf den Zusammenhang zwischen Anforderungen und Erschöpfung sowie von Anforderungen auf den Zusammenhang zwischen Ressourcen und Engagement. Xanthopoulou et al. (2007) untersuchten den Einfluss von persönlichen Ressourcen im Modell. Aktuell gilt das JD-R Modell in der arbeitsbezogenen Gesundheitspsychologie als besonders erklärungsstarker Ansatz zur Untersuchung von Zusammenhängen zwischen Eigenschaften der Arbeit und dem Wohlbefinden von Mitarbeitenden (Bakker et al., 2023; Lesener et al., 2019).

Abbildung 2.5

Das Anforderungs-Ressourcen Modell. In Anlehnung an Bakker & Demerouti, 2007, S. 313



2.4 Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung

Die Einführung von Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung ist häufig mit organisatorischen, personellen und finanziellen Kosten verbunden. Für eine erfolgreiche Implementierung sollten daher folgende Aspekte möglichst umfassend berücksichtigt werden: 1. ganzheitlicher Ansatz, der Individuum, Organisation und Umwelt mit ihren Wechselwirkungen und mögliche Auswirkungen auf andere Systemkomponenten berücksichtigt, 2. doppelte Zielsetzung, die Effizienz der Betriebsführung und Humanität der Arbeitsgestaltung realisieren möchte, 3. Beteiligung der Betroffenen an arbeitsbezogenen Fragen, sodass Verständnis, Identifikation und Zugehörigkeit gefördert werden können, 4. prozessorientiertes Vorgehen, das einen Wandel als gemeinsamen Entwicklungsverlauf versteht und das „Wie" der Veränderung fokussiert, 5. die Diagnose, die als Ausgangspunkt der Veränderung zu verstehen ist und dazu

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

beiträgt, ein gemeinsames Problembewusstsein zu schaffen und Veränderungsziele zu konkretisieren (H. Becker & Langosch, 2002).

Die Umsetzung von Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung ist von verschiedensten Faktoren wie Finanzierungs- oder Personalmöglichkeiten abhängig. Demzufolge bestehen keine einheitlichen Maßnahmen für alle Betriebe zur Entwicklung und Implementierung Betrieblicher Gesundheitsförderung.

2.4.1 Instrumente und Häufigkeit der Implementierung von Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung

Häufig verwendete Instrumente der Betrieblichen Gesundheitsförderung zur Diagnose des Ist-Zustandes sind Krankenstands- und Unfallanalysen, Gefährdungs- und Belastungsanalysen, Krankenkassendaten zu Krankheiten, ergonomische Analysen und Gruppendiskussionen. Mittel zur Einführung und Umsetzung von Maßnahmen sind Informationsveranstaltungen, Führungskräfteseminare, Arbeitsplatzgestaltung, Coaching, Teamentwicklung sowie Gesundheitszirkel (Kiesche, 2013).

Laut des Präventionsberichtes für das Jahr 2019 des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen (MDS; Bauer et al., 2020) waren Betriebe mit Betrieblicher Gesundheitsförderung zum Großteil im verarbeitenden Gewerbe (29 %) angesiedelt, gefolgt vom Gesundheits- und Sozialwesen (20 %) sowie „Weitere Dienstleistungen“ (17 %). Am häufigsten wurden Betriebe mit 100 bis unter 250 Beschäftigte erreicht. Ungefähr ein Drittel der Maßnahmen und Programme war auf spezifische Zielgruppen ausgerichtet. Dabei war die mittlere Führungsebene die häufigste Zielgruppe, da diese auch die Gesundheit ihrer Mitarbeiter:innen beeinflussen. Ein weiterer Anteil an Interventionen war an Personen gerichtet, die durch ihre Arbeit spezifischen Gesundheitsrisiken ausgesetzt sind, wie durch schweres Heben. Geschlechtsspezifische Gesundheitsförderung kam selten vor. In 65 % der Projekte gab es Entscheidungs- und Steuerungsgremien, wobei in den Gremien zu 86 % die Entscheidungsebene und 76 % Vertreter:innen der Krankenkassen präsent waren (hier war, wie bei den nachfolgenden Zahlen auch, eine Mehrfachnennung möglich). In einem Projekt wurden durchschnittlich drei Methoden zur Bedarfsermittlung verwendet. In erster Linie erfolgte die Bedarfsermittlung durch die Auswertung von Routinedaten der Krankenkassen, der Unfallversicherung und der Rentenversicherung (41 %), gefolgt von Betriebs-/ Arbeitsplatzbegehungen (38 %). Bei mehr als der Hälfte (54 %) der Programme wurden Verhaltens- und Verhältnismaßnahmen (siehe Kurs 2, Kapitel 1 „Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention“) miteinander kombiniert, 5 % der Aktivitäten waren rein verhältnisbezogen. Inhaltlich orientierten sich die verhältnisbezogenen Interventionen vorrangig an der gesundheitsförderlichen Gestaltung von Arbeitstätigkeit und -bedingungen (55 %), an der Gestaltung betrieblicher Rahmenbedingungen hin zu einer bewegungsförderlichen Umgebung (45 %) sowie an gesundheitsgerechter Führung (39 %). Verhaltensbezogene Interventionen beinhalteten vorrangig körperliche Aktivität bei der Arbeit und im Alltag (69 %) sowie Stressbewältigung und Ressourcenstärkung (52 %). Erfolgskontrollen erfolgten in 79 % der von Krankenkassen geförderten Programme, mit der häufigsten Erhebung der Zufriedenheit der Beschäftigten (76 %) und der Arbeitgeber:innen (66 %) mit der Intervention. Die Erfassung des Krankenstandes beziehungsweise der subjektiven Gesundheit erfolgte zu einem geringeren Anteil (38 % bzw. 20 %).

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

2.4.2 Gesundheitszirkel

Das Wissen über gesundheitliche Gefährdung der Beschäftigten in einer Organisation verteilt sich über verschiedene Stakeholder, wie Expert:innen im Arbeitsschutz, Führungsfunktionen mit häufig unzureichendem Bewusstsein über die gesundheitliche Relevanz ihrer Entscheidungen und Beschäftigte mit häufig ungenutztem Erfahrungswissen. Der Austausch zwischen den Stakeholdern ist meistens eingeschränkt. Gesundheitszirkel, das heißt die aktive Einbeziehung von Mitarbeiter:innen in Planung und Umsetzung Betrieblicher Gesundheitsförderung in der Form von moderierten Gruppendiskussionen, sind ein geeignetes Instrument, um das gesundheitsbezogene Erfahrungswissen der Beschäftigten in einer Feedbackschleife in das Wissen der Organisation einfließen zu lassen. Ziele eines solchen Zirkels sind beispielsweise die Reduzierung von Fehlzeiten und verhaltensbedingten Arbeitsunfällen sowie die Verbesserung der Arbeits- und Produktqualität, der Aufbau- und Ablauforganisation und der Kommunikation und Kooperation (Uhle & Treier, 2015).

Gesundheitszirkel können unter Beteiligung unterschiedlicher Gruppen durchgeführt werden; entweder mit Vertretern aller Stakeholder inklusive der Vorgesetzten („Düsseldorfer Modell") oder mit Beteiligten einer Hierarchieebene ohne Vorgesetzte („Berliner Modell"). Ein Zirkel besteht aus maximal 12 Mitarbeiter:innen eines Fachbereichs, die sich zu durchschnittlich sieben Sitzungen zusammensetzen. Die Mitarbeit in einem solchen Zirkel gilt als dienstliche Arbeitszeit. Ein Bericht über ermittelte Gesundheitsbelastungen und Vorschläge zu deren Beseitigung kommt dem betriebsinternen Arbeitskreis Gesundheit beziehungsweise dem Lenkungsausschuss zu. Dieser berät über die Umsetzung der Vorschläge. Nach einem halben Jahr erfolgt eine Evaluation der eingeleiteten Veränderungen sowie ein Jahr nach Beendigung der Zirkelarbeit eine Erfolgskontrolle der Arbeit. Für den Erfolg ist das Erkenntnisinteresse der Entscheidungsträger über die gesundheitliche Belastung der Beschäftigten entscheidend. Seit der Entwicklung des Instruments Gesundheitszirkel in den 1980er Jahren gehört es zum Standardrepertoire anspruchsvoller Prozesse zur Betrieblichen Gesundheitsförderung, deren Koordination der Geschäftsführung obliegt (Kiesche, 2013). Gesundheitszirkel wurden im Jahr 2019 bei 37 % der Programme der Betrieblichen Gesundheitsförderung eingerichtet (Bauer et al., 2020); empirische Forschung zu Gesundheitszirkeln existiert jedoch kaum.

2.4.3 Beispiel einer Maßnahme der Betrieblichen Gesundheitsförderung: Gehwettbewerb

Ein physisch inaktiver Lebensstil wird in vielen Ländern immer dominanter (WHO, 2010) In Deutschland berichteten bei einer repräsentativen Umfrage des Robert Koch-Instituts 16,7 % der Frauen und 22,3 % der Männer tägliche Sitzzeiten von acht Stunden oder mehr (Manz et al., 2022). Physische Inaktivität gilt als der viertgrößte Risikofaktor globaler Mortalität (WHO, 2010) und stellt einen primären Risikofaktor für nichtinfektiöse Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen dar (Smart & Marwick, 2004; siehe auch Kurs 1, Kapitel 9 „Physische Aktivität"). Im Sinne der Prävention solcher Gesundheitsrisiken nimmt seit kurzer Zeit die Förderung der körperlichen Aktivität von Beschäftigten durch Gehwettbewerbe im Betrieb zu.

Ein Beispiel für einen solchen Gehwettbewerbe bietet das Institut für Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF-Institut) – eine Ausgliederung der AOK mit der AOK Rheinland/Hamburg als Gesellschafterin (http://www.bgf-institut.de/). Das BGF-Institut erbringt Präventionsleistungen mit einem Fokus auf das gesunde Unternehmen. Der AOK-Gehwettbewerb „Schritt4fit" (http://www.schritt4fit.de/portal/faq/sogehts#challenge) ist ein firmeneigener Wettbewerb, bei dem in Teams eine gemeinsame virtuelle Route mit wählbarem Start und Ziel

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

(z. B. vom Firmenstandort zu einer europäischen Hauptstadt) ergangen wird. Der Fortschritt, gemessen in täglichen Schritten, wird auf der Webseite angezeigt. Als Anreize dienen eine persönliche Urkunde sowie ein Preis für das Team mit den meisten Schritten. Video 2.4 veranschaulicht einen solchen Gehwettbewerb.

Video 2.4. EASY GOING by mei:do (mei:do Institut Hamburg). Verfügbar unter https://youtu.be/CuafTxkA-Q8

2.5 Hochschule als gesundheitsförderndes Setting

Betriebliche Gesundheitsförderung und Betriebliches Gesundheitsmanagement wurden in den bisherigen Ausführungen im Kontext von Erwerbsarbeit betrachtet. Betriebe, in denen Menschen ausschließlich bezahlte Arbeit leisten, sind jedoch nicht die einzigen Organisationen, in denen Erwachsene einer strukturierten, längerfristig angelegten und mit Verpflichtungen verbundenen Tätigkeit nachgehen. Gerade Hochschulen werden im Zuge der zunehmenden Akademisierung der Arbeitswelt und des lebenslangen Lernens für immer mehr Menschen zu einer relevanten Lebenswelt; so gibt es aktuell an den insgesamt 428 deutschen Hochschulen knapp 2.9 Millionen Studierende und etwas über 720,000 Beschäftigte (Statistisches Bundesamt, 2024).

2.5.1 Bedingungen von Gesundheitsförderung an Hochschulen

Hochschulen besitzen spezifische Strukturen, die bei der Implementierung von Gesundheitsfördermaßnahmen berücksichtigt werden müssen. Dazu gehören eine mehrdimensionale Organisations- und Aufgabenstruktur sowie die Autonomie der einzelnen Wissenschaftsbereiche. Ersteres bezieht sich darauf, dass einerseits (staatliche) Hochschulen öffentliche Institutionen unter staatlicher Steuerung sind und andererseits die Mitarbeitenden und Studierenden der Körperschaft Hochschule mit spezifischen Mitwirkungsrechten angehören (Banscherus et al., 2009). Die Mehrdimensionalität der Aufgaben bezieht sich auch auf deren Ausdifferenzierung in die Bereiche Forschung, Lehre und Verwaltung. Des Weiteren sind Hochschulen in Fachdisziplinen mit entsprechenden Expert:innen organisiert. In diesem Zusammenhang wird von „strukturellem Widerspruch“ gesprochen, da im Wissenschaftsbereich flache Hierarchien mit verschiedensten Fachebenen existieren; im Vergleich dazu besteht in der Hochschulverwaltung eine typische bürokratische, hierarchische Struktur mit der Hochschulleitung (Rektorat, Präsidium) an oberster Stelle (Altvater, 2007).

Aus dem Präventionsgesetz von 2015 ergibt sich ein verpflichtender Leistungsanspruch gegenüber den gesetzlichen Krankenkassen, sich im Sinne des nichtbetrieblichen Setting-Ansatzes in Hochschulen zu engagieren (siehe zum Setting-Ansatz Kurs 2, Kapitel 1 „Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention“). Entsprechend § 20a Abs. 1 sind Lebenswelten „[…] für die Gesundheit bedeutsame, abgrenzbare soziale Systeme insbesondere des Wohnens, des Lernens, des Studierens, der medizinischen und pflegerischen Versorgung sowie der Freizeitgestaltung einschließlich des Sports“. Weitere (finanzielle) Unterstützung beim Aufbau eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements an Hochschulen wurde durch die Sozialversicherungsträger unter dem Leitbild der Entwicklung einer gesunden Organisation geleistet. Seit 2016 erfolgte ebenfalls Unterstützung durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (seit Februar 2025: Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit [BIÖG]; https://www.bioeg.de/).

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

2.5.2 Gesundheit von Hochschulangehörigen

Die Dreiteilung der Statusgruppen an Hochschulen in wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche Mitarbeiter:innen sowie Studierende muss auch bei der Betrachtung des Gesundheitszustandes und von Präventions- und Interventionsangeboten berücksichtigt werden.

Studierende

Die Gesundheit Studierender hat in den letzten Jahren in der gesundheitspsychologischen Forschung an Bedeutung gewonnen. Dies ist in Deutschland unter anderem auf die Einführung des Präventionsgesetzes (siehe oben) sowie der Umstrukturierung der Studienlandschaft im Zuge der Bologna-Reform zurückzuführen (Gusy et al., 2012). In den letzten Jahren sind drei nationale Gesundheitssurveys durchgeführt worden (Grützmacher et al., 2018; Techniker Krankenkasse, 2023b, 2015). Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich der Gesundheitszustand Studierender in den letzten Jahren verschlechtert hat. Gaben etwa 2015 noch 84 % der Teilnehmenden an, mit ihrer Gesundheit im Allgemeinen zufrieden zu sein, sank der Anteil 2023 auf 61 %. 2023 fühlten sich 44 % häufig gestresst; 2015 lag der Wert bei 23 % (Techniker Krankenkasse, 2023b, 2015). Als studienspezifische Stressoren werden Prüfungen, Mehrfachbelastungen durch Studium und Job und/oder Familie und Angst vor schlechten Noten genannt (Techniker Krankenkasse, 2023b, 2015). Studierende, die sich stressbelastet fühlen, weisen tendenziell ein erhöhtes Risiko für studienbezogene Schwierigkeiten, Substanzmissbrauch und emotionale Probleme auf (Chiauzzi et al., 2008). Insgesamt berichtete knapp ein Fünftel der Studierenden, mindestens einmal in ihrem Studium die Grenze ihrer Bewältigungsmöglichkeit erlebt zu haben (Ackermann & Schumann, 2010).

Wissenschaftliches Personal

Das wissenschaftliche Personal hat neben Forschung und Lehre ebenso die akademische Selbstverwaltung zur Aufgabe. Dabei gestaltet sich die Beschäftigungsstruktur der Professor:innen und des wissenschaftlichen Mittelbaus sehr heterogen, sodass für diese Beschäftigungsgruppen wenig empirisch abgesicherte Erkenntnisse vorliegen. Als zentrale Gesundheitsressourcen von Wissenschaftler:innen gelten eine hohe Sinnhaftigkeit und persönliche Identifikation sowie umfassende Entscheidungs- und Handlungsspielräume (Heise & Zaepernick-Rothe, 2012). Wichtige Belastungsfaktoren sind die erhöhte Betreuungsintensität der Bologna-Studiengänge sowie der zunehmende Druck durch die steigende Anzahl der Studierenden. Im Hinblick auf gesundheitsbeeinflussende Rahmenbedingungen kommt für die wissenschaftlichen Mitarbeitenden hinzu, dass drei Viertel von ihnen mit befristeten Verträgen und viele in Teilzeit angestellt sind, obwohl der Arbeitsumfang derjenigen einer Vollzeitstelle entspricht (Banscherus et al., 2009; Lesener & Gusy, 2017). (

Nichtwissenschaftliches Personal

Zur Gesundheit und arbeitsbezogenen Belastung von nichtwissenschaftlichem Personal gibt es am wenigsten belastbare Empirie. Ein Grund könnte darin bestehen, dass die Hochschulverwaltung ähnlich wie andere Einrichtungen des öffentlichen Dienstes in vielen Einheiten mit spezifischen Aufgaben (z. B. Verwaltung und Technik) und unterschiedlichen Hierarchieebenen organisiert ist. Die bisherige Forschung zeigt neben verwaltungstypischen Beanspruchungen (z. B. Rücken- und Nackenbeschwerden) hochschulspezifische Belastungen durch Veränderungen wie Arbeitszunahme infolge von Stellenabbau, fehlende Fortbildungsmöglichkeiten für neue Anforderungen und unzureichende Ansätze zur Personalentwicklung (Banscherus, 2024; Banscherus et al., 2009).

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

2.5.3 Übergreifende Initiativen zur Gesundheitsförderung an Hochschulen

In den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelte sich eine Reihe von internationalen und nationalen Initiativen zur Gesundheitsförderung an Hochschulen. Auf europäischer Ebene wurde, ausgehend von den Grundgedanken des Modellprojekts „Healthy Cities" (Gesunde-Städte-Projekt) der WHO (siehe Kurs 2, Kapitel 1 „Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention"), basierend auf dem Setting-Ansatz an den Modell-Hochschulen Lancaster and Central Lancashire in Großbritannien ein Konzept gesundheitsfördernder Hochschulen etabliert (Tsouros et al., 1998). Ähnliche Initiativen folgten an vielen Hochschulen weltweit. 2015 wurde die *Okanagan Charter* im Rahmen der International Conference on Health Promoting Universities and Colleges in Kanada verabschiedet (International Conference on Health Promoting Universities and Colleges, 2015). Video 2.5 verdeutlicht die Umsetzung der Prinzipien der Okanagan Charter an der Simon Frazer University in Kanada.

Video 2.5. A Healthy Campus Community at SFU (Simon Frazer University). Verfügbar unter http://youtu.be/1200TPhLJTc

In Deutschland besteht seit 1995 der von der Landesvereinigung für Gesundheit Niedersachsen organisierte *Arbeitskreis Gesundheitsfördernde Hochschulen (AGH*; http://www.gesundheitsfoerdernde-hochschulen.de). Dieser setzt sich als weltweit größtes Netzwerk dieser Art aus über 100 Hochschulen mit mehr als 400 Mitgliedern unterschiedlicher Statusgruppen und kooperierenden Institutionen wie Krankenkassen zusammen. Durch Vernetzung soll die Weiterentwicklung von Gütekriterien für eine gesundheitsfördernde Hochschule gefördert werden (Techniker Krankenkasse & Landesvereinigung für Gesundheit & Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e. V., 2013; siehe Kasten 2.4).

Eine gesundheitsfördernde Hochschule:

- arbeitet nach dem Setting-Ansatz,
- orientiert sich am Ressourcen- und Salutogenesekonzept,
- integriert Gesundheitsförderung in die Hochschulpolitik,
- berücksichtigt Gesundheitsförderung als strukturelle Querschnittsaufgabe bei allen Prozessen,
- beauftragt eine hochschulweit agierende Steuerungsgruppe für die Entwicklung gesundheitsförderlicher Strukturen und Prozesse,
- betreibt ein transparentes Informations- und Evaluationsmanagement,
- führt partizipativ ausgerichtete und sowohl an Verhaltens- als auch an Verhältnisdimensionen ausgerichtete gesundheitsfördernde Maßnahmen durch,
- ist dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet,
- integriert Gender Mainstreaming, Cultural Mainstreaming und die Gleichbehandlung von Menschen mit chronischen Erkrankungen und mit Behinderungen,
- vernetzt sich mit anderen Hochschulen und mit der Region beziehungsweise der Kommune.

Kasten 2.4. Gütekriterien für eine gesundheitsfördernde Hochschule. Nach TK & Landesvereinigung für Gesundheit & Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e. V., 2013.

2.5.4 Maßnahmen und Programme zur Gesundheitsförderung an deutschen Hochschulen

Die Gesundheitsförderung ist in Hochschulen noch nicht so umfassend realisiert, wie es notwendig und wünschenswert wäre. Allerdings gibt es eine Reihe von bereits etablierten

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Maßnahmen, die an die Grundsätze und Gütekriterien gesundheitsfördernder Hochschulen angelehnt sind. Zwei solcher Ansätze werden im Folgenden exemplarisch skizziert.

Healthy Campus Bonn

„Healthy Campus Bonn" ist die Betriebliche Gesundheitsförderung der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität (RFWU) Bonn sowie der „Healthy Campus Gesundheits- und Forschungsinitiative" mit den Trägern RFWU Bonn und Deutsche Sporthochschule Köln. Dieses seit 2011 bestehende Programm hat die Vermittlung und Implementierung eines nachhaltigen Gesundheitsbewusstseins und bewegungsbezogenen Lebensstils für alle Universitätsangehörigen im Sinne einer lebenslangen Verantwortungsübernahme für die eigene Gesundheit zum Ziel (Preuß et al., 2015). Ein wesentliches Anliegen des Healthy Campus-Programms ist die Erforschung und Verbesserung von Gesundheitskompetenz (Kuhlmann et al., 2015). Im Rahmen von „Healthy Campus Bonn" stehen Bewegungsangebote, Seminare, Informationsveranstaltungen und Beratungsangebote zu den Themen Ernährung, Bewegung und psychische Gesundheit zur Verfügung. So konnte etwa durch einen 60-tägigen Gehwettbewerb die Alltagsaktivität von 49 Beschäftigten gesteigert und das Körpergewicht reduziert werden (Preuß et al., 2015). Zum Bereich „Gesund arbeiten" zählen mobile Massage oder eine Seminarreihe Gesundheit mit Themen wie Ergonomie, Ernährung, Bewegung und Sport. Für den Bereich „Gesund studieren" werden beispielsweise Seminare zur Ressourcenstärkung und Angebote im Bereich Bewegung und Ernährung angeboten. Sowohl für die Beschäftigten als auch die Studierenden wird ein Rauchfrei-Programm, Betriebs- beziehungsweise Hochschulsport sowie eine aktive Pause, das ist ein 15- beziehungsweise 7-minütiges Bewegungsprogramm bestehend aus Übungen zur Mobilisation, Kräftigung, Dehnung und Entspannung, angeboten. Weiterhin bietet das Studierendenwerk Bonn im Rahmen von Healthy Campus-Wochen ein variierendes Angebot zum Thema Gesundheit an (https://www.uni-bonn.de/de/universitaet/ueber-die-uni/gesundheitsmanagement-healthy-campus/gesundheitsmanagement-healthy-campus).

Die Gesundheit Fernstudierender stärken: Das GFS-Projekt

Das Projekt „Die Gesundheit Fernstudierender stärken" (GFS) wurde Mitte 2016 am Lehrgstuhl Gesundheitspsychologie der heutigen Fakultät für Psychologie an der FernUniversität in Hagen initiiert. Ziele des GFS-Projekts waren, die Annahme von fernstudienspezifischen, stressbegünstigenden Belastungsfaktoren durch empirische Daten zu prüfen und Implikationen zur evidenzbasierten, digitalen Gesundheitsförderung für Fernstudierende abzuleiten. Dabei sollten die Gesundheitsmaßnahmen auf den spezifischen Kontext des Fernstudiums angepasst und in Kooperation mit der Zielgruppe weiterentwickelt werden. Insofern lag der Fokus auf niederschwelligen, barrierefreien Angeboten. Diese Gesundheitsförderung sollte langfristig zu verbesserten Gesundheitskompetenzen und gesundheitsbezogener Lebensqualität der Fernstudierenden beitragen.

Der Gesundheitssurvey des ersten Projektteils (Apolinário-Hagen et al., 2018; N = 5,721) ergab als Hauptstressoren vor allem Zeitmangel (63.7 %), Leistungsdruck (40.6 %), Sorgen beziehungsweise Zukunftsängste (29.3 %), Unsicherheit (27.8 %) und Überforderung (26.1 %). Die bedeutendsten wahrgenommen Stressquellen umfassten die Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie beziehungsweise sozialem Leben. Fast ein Drittel der Befragten (31.4 %) gab an, bereits eine so starke emotionale Belastung während ihres Studiums erlebt zu haben, dass sie diese mit ihren üblichen Strategien (z. B. Entspannungsmethoden) nicht mehr selbständig bewältigen konnten. Darüber hinaus erklärte sich die Mehrheit der Befragten (68.6 %) interessiert, zukünftig app- oder webbasierte Gesundheitsförderangebote der FernUniversität zu

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

nutzen mit einer klaren Präferenz für app- beziehungsweise smartphonebasierte Gesundheitsinterventionen (46.1 %) und kombinierte online- und face-to-face Gesundheitskurse (30.7 %). Basierend auf der Bedarfs- und Bedürfnisermittlung wurde ein Präventionsangebot im Handlungsfeld multimodales Stressbewältigungstraining zum Umgang mit Mehrfachbelastungen in Form eines app- und webbasierten Gesundheitsprogramms (siehe Kurs 2, Kapitel 6 „eHealth") entwickelt. Die App *Stressdown* ist in allen gängigen App-Stores verfügbar (Salewski et al., 2023; Salewski & Schnädter, 2024). 2024 wurde ein zweiter Gesundheitssurvey durchgeführt. Die Ergebnisse zeigten, dass sich die gesundheitliche Lage der Studierenden der FernUniversität in Hagen im Vergleich zu 2016 im Allgemeinen nicht wesentlich verschlechtert hat. Belastungen zeigten sich in Form von einem erhöhten Stressempfinden (22 %), Erschöpfungssymptomen (15 %), Anzeichen für niedergedrückte Stimmung (28 %) und Anzeichen für ängstliche Stimmung (30 %) (Schnädter & Salewski, 2025). Weiterführende Informationen zum Projekt und der App *Stressdown* finden Sie unter https://www.fernuni-hagen.de/gesundheitspsychologie/forschung/gesundheitsfoerderung/index.shtml.

Literaturverzeichnis

Ackermann, E. & Schumann, W. (2010). Die Uni ist kein Ponyhof: Zur psychosozialen Situation von Studierenden. *Prävention und Gesundheitsförderung*, *5*(3), 231–237. https://doi.org/10.1007/s11553-010-0234-5

Altvater, P. (2007). Organisationsberatung im Hochschulbereich: Einige Überlegungen zum beratungsverständnis und zu Handlungsproblemen in Veränderungsprozessen. In P. Altvater, Y. Bauer & H. Gilch (Hrsg.), *Organisationsentwicklung in Hochschulen* (S. 11–24). HIS.

Apolinário-Hagen, J., Groenewold, S. D., Fritsche, L., Kemper, J., Krings, L. & Salewski, C. (2018). Die Gesundheit Fernstudierender stärken. *Prävention und Gesundheitsförderung*, *13*(2), 151–158. https://doi.org/10.1007/s11553-017-0620-3

Badura, B., Walter, U. & Hehlmann, T. (2010). *Betriebliche Gesundheitspolitik*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-04337-6

Bakker, A. B. & Demerouti, E. (2007). The Job Demands-Resources Model: State of the art. *Journal of Managerial Psychology*, *22*(3), 309–328. https://doi.org/10.1108/02683940710733115

Bakker, A. B., Demerouti, E. & Sanz-Vergel, A. (2023). Job Demands–Resources Theory: Ten years later. *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*, *10*(1), 25–53. https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-120920-053933

Bamberg, E., Ducki, A. & Metz, A. M. (2011). Gesundheitsförderung und Gesundheitsmanagement: Konzeptuelle Klärung. In E. Bamberg, A. Ducki & A. M. Metz (Hrsg.), *Gesundheitsförderung und Gesundheitsmanagement in der Arbeitswelt: Ein Handbuch* (S. 123–134). Hogrefe.

Banscherus, U. (2024). Personalentwicklung für Beschäftigte in wissenschaftsunterstützenden Bereichen als blinder Fleck der Hochschulentwicklung. *Zeitschrift für Hochschulentwicklung*, *19*(4), 115–135. https://doi.org/10.21240/zfhe/19-4/07

Banscherus, U., Dörre, K., Neis, M. & Wolter, A. (2009). *Arbeitsplatz Hochschule: Zum Wandel von Arbeit und Beschäftigung in der "unternehmerischen Universität"*. http://library.fes.de/pdf-files/wiso/06669.pdf

Bauer, S., Geiger, L., Nuggemann, R., Seidel, J. & Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen e.V. (2020). *Präventionsbericht 2020: Leistungen der sozialen Pflegeversicherung: Primärprävention und betriebliche Gesundheitsförderung;*

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440